

Çocuklarda Ülseratif Kolit — Tanı ve Tedavi Algoritması

Porto ölçütleriyle tanı, **PUCAI** ile şiddet sınıflaması ve ECCO/ESPGHAN temelli basamaklı tıbbi tedavi; akut ağır kolitin ivedi yönetimi vurgulanır.

Porto ölçütleri

PUCAI şiddet skoru

ECCO / ESPGHAN 2018

İnflamatuvar bağırsak hastalığı

01 Tanı ve değerlendirme

Kronik (≥ 4 hafta) veya tekrarlayan **kanlı ishal**, karın ağrısı, tenesmus, aciliyet; sistemik bulgular ve büyüme geriliği olabilir. Tanı **Porto ölçütlerine** göre konur.

Tanı süreci (Porto)

- Öncelikle **enfeksiyonu dışla** (dışkı kültürü, **C. difficile**, parazit).
- İleokolonoskopi + üst GİS endoskopisi**, çok sayıda segmentten biyopsi.
- Crohn'u dışlamak için **ince bağırsak görüntülemesi** (MR enterografi).
- ÜK: rektumdan başlayan, sürekli, yüzeyel mukozal inflamasyon (kolona sınırlı).

Başlangıç tetkikleri

- Kan:** TKS, CRP/ESR, albümin, karaciğer/böbrek, demir.
- Dışkı:** kalprotektin, kültür + C. difficile toksini.
- Tedavi öncesi: TPMT/tiyopürin metaboliti, hepatit B, TB (biyolojik öncesi), aşı durumu.
- Büyüme, beslenme, kemik sağlığı ve psikososyal değerlendirme.

PUCAI (Pediatric Ulcerative Colitis Activity Index) 0–85 puan; tedavi kararı ve yanıt izlemi bu skora dayanır.

Remisyon

< 10

Hastalık aktif değil;
idame hedefi.

Hafif

10–34

Ayaktan; 5-ASA ile
indüksiyon.

Orta

35–64

Oral steroid /
yükseltme
gerekebilir.

Ağır

≥ Akut ağır

65

kolit —
hastaneye
yatış.

PUCAI bileşenleri (özet)

PARAMETRE	ARALIK	PUAN
Karın ağrısı	Yok / hafif / şiddetli	0–10
Rektal kanama	Yok → çoğunlukla kan	0–30
Dışkı kıvamı	Şekilli → tümü sulu	0–10
Gün içi dışkı sayısı	0–2 → >8	0–15
Gece dışkılama (uykudan uyandıran)	Yok / var	0–10
Aktivite düzeyi	Kısıtsız → kısıtlı	0–10

Tanıyı doğrula → PUCAI ile şiddeti belirle → şiddete göre indüksiyon → yanıtı PUCAI ile izle → yanıtızlılıkta yükselt; hedef **steroidsiz remisyon ve mukozal iyileşme**.

BAŞLANGIÇ

Tanı doğrulandı → PUCAI hesapla

Enfeksiyon (özellikle *C. difficile*) dışlandı. Hastalık yaygınlığı ve şiddeti belirlendi.

KARAR 1

PUCAI $\geq$ 65 (akut ağır kolit) mi?

EVET → hastaneye yatış

HAYIR → şiddete göre

AKUT AĞIR KOLİT

IV kortikosteroid + yakın izlem

Yatır; IV metilprednizolon. *C. difficile*'yi tekrar dışla. **3. ve 5. günde PUCAI** ile yanıtı değerlendir.

AYAKTAN

Hafif-orta indüksiyon

PUCAI 10–64: 5-ASA temelli indüksiyona başla.

ADIM 1 · HAFİF-ORTA İNDÜKSİYON

Oral + topikal 5-ASA (mesalazin)

Oral 5-ASA + proktit/sol kolonda **topikal 5-ASA** (lavman/supozituar). 2–4 haftada PUCAI ile yanıtı değerlendir.

KARAR 2

5-ASA ile yeterli yanıt var mı?

EVET → idame

HAYIR → yükselt

İDAME

5-ASA idamesini sürdür

Steroidsiz remisyonu koru; kalprotektin ve büyüme ile izle.

ADIM 2

Oral kortikosteroid ile indüksiyon

Oral prednizolon (veya uygun olgularda budesonid-MMX). Steroid **idame tedavisi değildir** — kademeli azalt.

KARAR 3

Steroide bağımlı / dirençli mi?

EVET → biyolojik / immünmodülatör

HAYIR → idame

ADIM 3 · YÜKSELTME

Anti-TNF (infliksimab) ± tiyopürin

Steroid bağımlı/dirençli hastalıkta **anti-TNF** başlat; idamede tiyopürin veya anti-TNF sürdür. Yanıtsızlıkta ikinci biyolojik (vedolizumab vb.).

İDAME

Steroidsiz remisyonu sürdür

5-ASA ± tiyopürin ile idame; düzenli izlem.

AKUT AĞIR KOLİT YOLU · 3.-5. GÜN

IV steroide yanıtsızsa ikinci basamak

PUCAI 3. günde >45 ise ikinci basamağı planla; 5. günde >65 ise başlat: **infliksimab** veya kalsinörin inhibitörü (siklosporin/takrolimus). Yanıt yoksa **kolektomi**.

04 Tedavi basamakları (özet)

Şiddete göre indüksiyon ve idame

DURUM	İNDÜKSİYON	İDAME
Hafif-orta	Oral + topikal 5-ASA	5-ASA
5-ASA yetersiz	Oral kortikosteroid (veya budesonid-MMX)	5-ASA ± tiyopürin
Steroid bağımlı/dirençli	Anti-TNF (infliksimab/adalimumab)	Anti-TNF ± tiyopürin
Akut ağır kolit (PUCAI ≥ 65)	Yatış + IV kortikosteroid	Yanıta göre biyolojik
IV steroide dirençli	İnfliksımab veya kalsinörin inhibitörü	Anti-TNF / tiyopürin
Tıbbi tedaviye dirençli	Kolektomi (cerrahi değerlendirme)	

Tedavi hedefi: yalnızca klinik remisyon değil, **steroidsiz remisyon + mukozal iyileşme** (kalprotektin ve endoskopik iyileşme). Steroidler indüksiyon içindir, idamede kullanılmaz.

05

İzlem ve dikkat gerektirenler

Rutin izlem

- **Fekal kalprotektin** ve klinik aktivite (PUCAI) ile takip.
- Büyüme, kemik sağlığı (D vitamini), demir eksikliği.
- Tiyopürin: TPMT, TKS ve karaciğer izlemi.
- **Kolorektal kanser taraması**: uzun süreli yaygın kolitte sürveyans kolonoskopisi.

Aşı ve enfeksiyon

- İmmünsupresyon öncesi **aşıları tamamla**; canlı aşılarla dikkat.
- Biyolojik öncesi **TB ve hepatit B** taraması.
- Alevlenmede **C. difficile** ve CMV'yi tekrar değerlendir.
- Tromboz riski (ağır atakta) göz önünde bulundurulur.

06

Kırmızı bayraklar / komplikasyonlar

● **PUCAI $\geq$ 65** — akut ağır kolit, yatış

● **Toksik megakolon** — distansiyon, sistemik toksisite

● Ağır kanama, ciddi anemi, transfüzyon ihtiyacı

● Perforasyon / peritonit bulguları

● Ağır hipoalbuminemi, hızlı kilo kaybı

● IV steroide 3–5 günde yanıtızlık

● Süperenfeksiyon: **C. difficile** / CMV koliti

● < 6 yaş / atipik seyir → **monogenik IBD** (VEO-IBD) düşün

IBD şüphesi olan her çocuk → pediatrik gastroenteroloji

Akut ağır kolit → ivedi yatış (deneyimli merkez)

Steroid dirençli/bağımlı → biyolojik için merkez

Cerrahi ihtiyacı → çok disiplinli değerlendirme

VEO-IBD (< 6 yaş) → immünoloji/genetik

Uyarı: Bu şema eğitim ve hızlı başvuru amaçlıdır; bireysel klinik karar, güncel kılavuzlar ve yerel protokollerin yerine geçmez. İlaç seçimi, dozları ve biyolojik tedavi kararları deneyimli pediatrik gastroenteroloji ekibince verilmelidir.

Kaynaklar

1. Turner D, Ruemmele FM, Orlanski-Meyer E, ve ark. Management of Paediatric Ulcerative Colitis, Part 1: Ambulatory Care — ECCO-ESPGHAN Guideline. *JPGN*. 2018;67(2):257–291.
2. Turner D, Ruemmele FM, Orlanski-Meyer E, ve ark. Management of Paediatric Ulcerative Colitis, Part 2: Acute Severe Colitis — ECCO-ESPGHAN Guideline. *JPGN*. 2018;67(2):292–310.
3. Levine A, Koletzko S, Turner D, ve ark. ESPGHAN Revised Porto Criteria for the Diagnosis of Inflammatory Bowel Disease in Children and Adolescents. *JPGN*. 2014;58(6):795–806.
4. Turner D, Otley AR, Mack D, ve ark. Development and Validation of the Pediatric Ulcerative Colitis Activity Index (PUCAI). *Gastroenterology*. 2007;133(2):423–432.